

TEMA 9.63 • RESPIRATORIO

Manejo de la Rinitis Alergica

PERFIL EUNACOM 1.09.63  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Prick Test**, también conocido como test de punctura cutánea, es la herramienta diagnóstica de elección para identificar la **sensibilización mediada por IgE** frente a diversos alérgenos. Es una prueba fundamental en el estudio de patologías como la **Rinitis Alérgica**, el **Asma** bronquial y las alergias alimentarias.

¿Qué evalúa el Prick Test?

- Su objetivo principal es demostrar la presencia de **sensibilización**. Es fundamental entender que una prueba positiva no equivale automáticamente a una alergia clínica; la interpretación siempre debe realizarse en el contexto de la historia del paciente.
- Se utiliza para testear diferentes categorías de alérgenos:
  - Alérgenos respiratorios (Aeroalérgenos):** Ácaros del polvo, pólenes (gramíneas, malezas, árboles), epitelios de animales (perro, gato) y hongos.
  - Alérgenos alimentarios:** Leche de vaca, huevo, frutos secos, pescados, mariscos, legumbres, entre otros.
  - Alérgenos de exposición laboral:** Látex, harinas, enzimas industriales.

NOTA CLÍNICA

**Fisiopatología:** El Prick Test reproduce a pequeña escala una reacción de hipersensibilidad tipo I (inmediata). Al introducir el alérgeno en la epidermis, este interactúa con la IgE específica unida a la superficie de los **mastocitos** cutáneos. Si hay sensibilización, el mastocito se degranula liberando histamina y otros mediadores que provocan vasodilatación y edema local (la "roncha").

Técnica del Procedimiento

- El procedimiento es mínimamente invasivo y se realiza generalmente en la cara anterior del antebrazo.
- Limpieza:** Se limpia la piel con alcohol o agua.
  - Marcación:** Se marcan los puntos donde se aplicarán las gotas de los extractos alérgenos, dejando una separación de al menos 2 cm entre cada uno para evitar la coalescencia de reacciones.
  - Aplicación de gotas:** Se coloca una gota de cada extracto, incluyendo siempre los controles.
  - Puntura (Lanceta):** Con una lanceta estéril o aguja fina, se realiza una mínima escoriación epidérmica a través de la gota. Es crucial **no producir sangrado** y cambiar el dispositivo (o limpiar meticulosamente) entre cada alérgeno para evitar la contaminación cruzada.
  - Espera:** Se deja actuar por un periodo de **15 a 20 minutos**.
  - Lectura:** Se mide el diámetro de la pápula (roncha) resultante.

Interpretación de los Resultados

Para que la prueba sea válida, los controles deben funcionar correctamente.

Criterio de Positividad

Se considera que un paciente está **sensibilizado** a un alérgeno si: - El control positivo es adecuado. - El control negativo es negativo. - El alérgeno produce una **roncha con un diámetro mayor o igual a 3 milímetros**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

**Perla EUNACOM:** El Prick Test detecta **sensibilización**, no necesariamente enfermedad. El diagnóstico de "Alergia" es **clínico**. Si el test es positivo pero el paciente no presenta síntomas al exponerse al alérgeno, se dice que está sensibilizado pero no es alérgico.

Limitaciones y Consideraciones

Existen factores que pueden alterar el resultado, llevando a falsos negativos o situaciones de riesgo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

**Interferencia Farmacológica:** Los **antihistamínicos** (H1) deben suspenderse al menos 3 a 7 días antes de la prueba, ya que bloquean la respuesta de la histamina y pueden dar falsos negativos. Otros fármacos como antidepresivos tricíclicos también pueden interferir.

- Edad:** En lactantes muy pequeños o ancianos, la reactividad cutánea puede estar disminuida.
- Estado de la piel:** No se debe realizar en zonas con eccema activo, dermatografismo severo o quemaduras solares.
- Riesgo de Anafilaxia:** Aunque es extremadamente raro con la técnica de prick (a diferencia de las pruebas intradérmicas), siempre debe realizarse en un entorno médico que cuente con equipo de reanimación y adrenalina disponible.

Resumen de Utilidad Clínica

- **Asma y Rinitis Alérgica:** Identifica los gatillantes ambientales para guiar medidas de control ambiental y evaluar la posibilidad de inmunoterapia (vacunas de alergia). - **Alergia Alimentaria:** Ayuda a identificar el alimento sospechoso, aunque a menudo requiere confirmación con pruebas de provocación oral si la clínica es dudosa. - **Seguimiento:** Permite evaluar si un paciente ha desarrollado tolerancia espontánea (común en alergias alimentarias infantiles).

NOTA CLÍNICA

Si un paciente tiene una historia clínica muy sugerente de alergia pero el Prick Test es negativo, se puede solicitar una **IgE específica en sangre** (ImmunoCAP) para complementar el estudio.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de 25 años con rinitis alérgica diagnosticada clínicamente presenta obstrucción nasal severa como síntoma predominante, además de rinorrea acuosa y estornudos frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo de la Rinitis Alergica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

| TABLA 9.63.1: ELEMENTO VS SUSTANCIA |                       |                    |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ELEMENTO                            | SUSTANCIA             | RESULTADO ESPERADO | UTILIDAD                                                                    |
| Control Positivo                    | Histamina (10 mg/ml)  | Roncha $\geq$ 3 mm | Confirma que la piel es reactiva y que no hay fármacos interfiriendo.       |
| Control Negativo                    | Suero Fisiológico     | Roncha de 0 mm     | Asegura que el paciente no presenta dermatografismo (reacción por el roce). |
| Alérgenos                           | Extractos específicos | Variable           | Evalúa la sensibilización específica.                                       |

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- El diagnóstico de rinitis alérgica es clínico; el prick test identifica alérgenos y descarta alergia en rinitis no alérgica
- Antihistamínicos de segunda generación: loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, fexofenadina (anti-H1, no confundir con anti-H2)
- Corticoides tópicos nasales: fluticasona, mometasona, budesonida; son más eficaces que los antihistamínicos
- Corticoides tópicos son de elección en rinitis grave y cuando predomina la obstrucción nasal
- Se puede iniciar con antihistamínicos o corticoides y agregar el otro si no hay respuesta
- Corticoides orales (prednisona) solo en casos refractarios graves o con pólipos nasales
- Los pólipos nasales impiden la llegada del corticoide tópico, requiriendo inicio con corticoide oral

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DE LA RINITIS ALÉRGICA)****PREGUNTA 1**

Un paciente de 25 años con rinitis alérgica diagnosticada clínicamente presenta obstrucción nasal severa como síntoma predominante, además de rinorrea acuosa y estornudos frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?

- A)** Antihistamínicos de primera generación (clorfenamina)
- B)** Antihistamínicos de segunda generación (loratadina)
- C)** Corticoide tópico nasal (fluticasona)
- D)** Corticoides orales (prednisona)
- E)** Descongestionante tópico (oximetazolina)

**PREGUNTA 2**

¿En cuál de las siguientes situaciones está indicado iniciar corticoides ORALES en una rinitis alérgica?

- A)** Rinitis alérgica estacional leve de reciente diagnóstico
- B)** Rinitis alérgica con prurito nasal como síntoma predominante
- C)** Rinitis alérgica grave asociada a pólipos nasales que no responde a tratamiento tópico
- D)** Rinitis alérgica perenne en un paciente que prefiere medicación oral
- E)** Rinitis alérgica en paciente con asma leve intermitente

**PREGUNTA 3**

Un médico general indica ranitidina a un paciente con rinitis alérgica. ¿Cuál es el error en esta indicación?

- A)** La ranitidina es un anti-H2, no un anti-H1; no tiene efecto sobre la alergia
- B)** La ranitidina es un antihistamínico de primera generación y causa mucha somnolencia
- C)** La ranitidina está contraindicada en pacientes alérgicos
- D)** La ranitidina solo funciona por vía endovenosa, no oral
- E)** La ranitidina es un corticoide, no un antihistamínico

**RESUMEN: MANEJO DE LA RINITIS ALERGICA**

Esta clase aborda el manejo farmacológico de la rinitis alérgica. El diagnóstico es absolutamente clínico, sin necesidad de exámenes. El prick test tiene dos utilidades: identificar el alérgeno específico (para medidas de evitación) y descartar causa alérgica cuando la clínica sugiere rinitis no alérgica, ya que las rinitis no alérgicas son un diagnóstico de descarte que requiere prick test negativo. El tratamiento farmacológico se basa en dos pilares: antihistamínicos de segunda generación (loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, fexofenadina) y corticoides tópicos nasales (fluticasona, mometasona, budesonida). Es fundamental no confundir los anti-H1 (antihistamínicos para alergia) con los anti-H2 (ranitidina, famotidina, para reflujo). Los antihistamínicos de segunda generación se administran una vez al día y son económicos. Los corticoides tópicos son más eficaces que los antihistamínicos y son de elección en dos situaciones: rinitis alérgica grave con muchos síntomas y cuando predomina la obstrucción nasal (los corticoides tienen mayor efecto sobre la obstrucción). Se puede iniciar con cualquiera de los dos fármacos y agregar el otro si no hay respuesta adecuada. Los corticoides orales (prednisona) se reservan para casos refractarios graves o cuando hay pólipos nasales, ya que los pólipos impiden el paso del corticoide tópico.